

TEMA 2.9 • DIABETES Y DISLIPIDEMIAS

Tratamiento de la Diabetes en Embarazadas

PERFIL EUNACOM 1.04.2.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Tratamiento de la Diabetes en el Embarazo

Objetivos glicémicos (más estrictos que fuera del embarazo)

TABLA 2.9.1: GLICEMIA VS OBJETIVO	
GLICEMIA	OBJETIVO
Pre-prandial	< 90 mg/dL
Post-prandial (2h)	< 120 mg/dL

- Control con **hemoglucómetro domiciliario** 4 veces/día - **HbA1c no es útil aquí** (cambia demasiado lento para la duración del embarazo) — se pide c/6–8 semanas como respaldo, pero toma de decisiones va con glicemias - Control clínico cada **2 semanas** con registro de glicemias

Tratamiento

- **Dieta estricta primero**
- Si no logra metas → **Insulina** (de preferencia):
 - - **NPH** (1 o 2 dosis) → de elección en embarazo
 - - + Insulina **crystalina** si postrandiales no se corrigen
 - - Evitar en lo posible glargina (menos evidencia de seguridad)
- HGO permitidos (con evidencia de seguridad): **Metformina** y **Glibenclamida** — pero se prefiere siempre insulina en embarazo

Manejo del parto

- El parto es un estado de estrés/consumo de glucosa → riesgo de hiper e hipoglicemia
- Controlar glicemia frecuentemente durante el trabajo de parto
- Habitualmente no se requiere insulina adicional durante el parto (el útero consume glucosa activamente)

Pre-concepción (diabética que se quiere embarazar)

- HbA1c < 7% **antes** de embarazarse
- Preferir manejo con insulina previo al embarazo
- Iniciar ácido fólico **4 mg/día** (10x la dosis normal) para prevenir defectos del tubo neural

Post-parto (en DMG)

- TTOG 6–12 semanas post-parto → descartar DM2 de base
- La DMG es un factor de riesgo para DM2 futura

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Paciente de 30 años, cursando embarazo de 26 semanas, se realiza PTGO 75 g con resultado: ayunas 96 mg/dL, 1 hora 160 mg/dL, 2 horas 140 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tratamiento de la Diabetes en Embarazadas. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La diabetes gestacional se diagnostica con PTGO 75 g entre semanas 24-28
- Un solo valor alterado en la PTGO hace el diagnóstico según criterios IADPSG
- El tratamiento inicial es terapia nutricional con dieta fraccionada
- Las metas son: ayunas <95, 1h postprandial <140, 2h postprandial <120 mg/dL
- La insulina es el fármaco de elección cuando la dieta falla
- La metformina es alternativa de segunda línea, cruza la placenta
- Las sulfonilureas están contraindicadas en el embarazo
- Se debe reclasificar con PTGO a las 6-12 semanas postparto

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN EMBARAZADAS)

PREGUNTA 1

Paciente de 30 años, cursando embarazo de 26 semanas, se realiza PTGO 75 g con resultado: ayunas 96 mg/dL, 1 hora 160 mg/dL, 2 horas 140 mg/dL. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ A) Repetir PTGO en 4 semanas
- ☐ B) Iniciar metformina inmediatamente
- ☐ C) Indicar terapia nutricional y automonitoreo glicémico
- ☐ D) Iniciar insulina NPH de inmediato
- ☐ E) Iniciar glibenclamida

PREGUNTA 2

Embarazada de 28 semanas con diabetes gestacional diagnosticada hace 2 semanas. A pesar de cumplir dieta, sus glicemias en ayunas oscilan entre 100-110 mg/dL. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección?

- ☐ A) Metformina 850 mg cada 12 horas
- ☐ B) Insulina NPH nocturna
- ☐ C) Glibenclamida 5 mg al día
- ☐ D) Sitagliptina 100 mg al día
- ☐ E) Aumentar restricción calórica solamente

PREGUNTA 3

¿Cuándo se debe reclasificar a una paciente que tuvo diabetes gestacional después del parto?

- ☐ A) Inmediatamente después del parto
- ☐ B) A las 6-12 semanas postparto con PTGO 75 g
- ☐ C) Al año del parto con glicemia de ayunas
- ☐ D) No requiere seguimiento si la glicemia se normaliza
- ☐ E) A los 6 meses con hemoglobina glicosilada

RESUMEN: TRATAMIENTO DE LA DIABETES EN EMBARAZADAS

La diabetes gestacional (DG) se define como cualquier grado de intolerancia a la glucosa reconocido por primera vez durante el embarazo. Se diagnostica mediante una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTGO) con 75 g entre las semanas 24 y 28, considerando valores alterados si la glicemia en ayunas es mayor o igual a 92 mg/dL, a la hora mayor o igual a 180 mg/dL, o a las 2 horas mayor o igual a 153 mg/dL según criterios IADPSG. Es fundamental diferenciarla de la diabetes pregestacional (tipo 1 o tipo 2 previa al embarazo). El pilar del tratamiento es la terapia médica nutricional con una dieta fraccionada, controlando los hidratos de carbono y asegurando un aporte calórico adecuado. Se recomienda automonitoreo glicémico 4 veces al día. Las metas son glicemia en ayunas menor a 95 mg/dL, 1 hora postprandial menor a 140 mg/dL y 2 horas postprandial menor a 120 mg/dL. Cuando la dieta no logra las metas en 1 a 2 semanas, se indica insulina como fármaco de elección. La insulina NPH y la insulina cristalina son las más utilizadas. La metformina puede considerarse como alternativa cuando la paciente rechaza la insulina o no tiene acceso, aunque cruza la placenta. Las sulfonilureas están contraindicadas. El manejo debe ser multidisciplinario con control obstétrico frecuente.